



PATIENTENINFORMATION

Patientin	Baumgartner, Renate	Geburtsdatum	22.07.1972 (52 Jahre)
Adresse	Berliner Allee 12, 40212 Düsseldorf, NRW	KVNR	G000123456 (Techniker Krankenkasse)
Patientenakte-Nr.	SMK-DUS-2024-034721	Behandelnder Arzt	Dr. med. Markus Hoffmann, Gastroenterologe
Aufnahmedatum	25.09.2024 (Stationäre Aufnahme)	Zuweiser	Dr. med. Petra Lange, Hausarzt, Düsseldorf

1 — ANAMNESE UND SYMPTOMATIK

Patientin stellt sich mit seit 6 Wochen bestehenden linksseitigen Unterbauchschmerzen (krampfartig, NRS 5–7/10) sowie verändertem Stuhlverhalten vor (Wechsel zwischen Obstipation und Diarrhoe, ca. 4–5 Stühle/Tag). Seit 2 Wochen Beimengung von hellrotem Blut im Stuhl. Gewichtsverlust ca. 4 kg in 8 Wochen. Positive Familienanamnese: Vater mit Kolonkarzinom (Diagnose mit 58 Jahren). Keine bekannten Vorerkrankungen; keine Dauermedikation. Kein Alkohol, Nichtraucherin. Letzte Darmspiegelung: vor ca. 10 Jahren (ohne Befund).

2 — UNTERSUCHUNGSBEFUNDE

Befund	Ergebnis	Referenz
Allgemeinzustand	Reduziert, Blässe	—
Abdomen	LUQ: DS+, Abwehrspannung –	Weich, kein DS
Rektal-digital	Keine Raumforderung palpabel, Stuhl blutig tingiert	Neg.
Hb	10,4 g/dL	12–16 g/dL
Leukozyten	$11,2 \times 10^9/L$	$4–11 \times 10^9/L$
CRP	42 mg/L	< 5 mg/L
CEA (Tumormarker)	12,8 µg/L (↑)	< 3,4 µg/L
CA 19-9	28,3 kU/L (normal)	< 37 kU/L
Haemokult (Stuhltest)	Stark positiv	Negativ

3 — DIFFERENTIALDIAGNOSEN

Erste Diagnose:	Kolonkarzinom (bevorzugt Sigma/Deszendenz) — hohe Wahrscheinlichkeit aufgrund klinischer Konstellation, erhöhtem CEA, Familienanamnese und okkultem Blutnachweis.
Zweite Diagnose:	Divertikelkrankheit mit Komplikation (Divertikulitis Sigma) — kann ähnliche Symptome verursachen, jedoch erhöhtes CEA untypisch.
Dritte Diagnose:	Chronisch-entzündliche Darmerkrankung (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) — Altersmanifestationen möglich, Blutungscharakter passt.
Auszuschliessen:	Infektiöse Kolitis, ischämische Kolitis, Hämorrhoiden als alleinige Blutungsursache.

4 — DIAGNOSTISCHES VORGEHEN

Dringende Koloskopie mit Biopsieentnahme (geplant 27.09.2024). CT-Abdomen/Becken mit Kontrastmittel zur Staging-Beurteilung. MRT Rektum wenn rektale Beteiligung nachgewiesen. Vorstellung im

Interdisziplinäres Tumorboard (Kolon/Rektum) nach Histologie. Eisensubstitution i.v. wegen Eisenmangelanämie eingeleitet. Genetische Beratung empfohlen (Lynch-Syndrom-Ausschluss).

⚠ SYNTHETIC DOCUMENT — All patient data, names, identification numbers and clinical details in this document are entirely fictional and have been generated for AI research purposes. Any resemblance to real persons is purely coincidental. Not for clinical use.